QUESTÕES DA PROVA

N1 - Módulo 1, turma C | 16/06/2023

QUESTÃO 01

Uma paciente de 58 anos apresenta-se no ambulatório com história de dor no joelho direito há anos com piora há 4 meses, associado a rigidez matinal de 25 minutos. Durante a deambulação, há intensificação da dor. Ao exames do joelho direito, observa-se crepitação a movimentação ativa e passiva. Qual o diagnóstico?

A) Artrite reumatoide

B) Doença por pirofosfato de cálcio

C) Osteoartrite

D) Condromalácia de patela

QUESTÃO 02

Uma paciente de 38 anos relata 2 anos de evolução de dor e aumento de volume das articulações 2as, 3as, e 4as metacarpofalangeanas, os punhos e as 3as e 4as interfalangeanas, de forma aditiva. Relata dificuldade para realizar as atividades no período matinal com rigidez de 2 horas. Nega xeroftalmia, xerostomia, úlceras orais, fotossensibilidade, manchas na pele e fenômeno de Raynaud. Ao exame observa-se artrite das articulações envolvidas, desvio ulnar bilateral. Qual dos achados abaixo não é esperado para o caso?

A) Radiografia com erosão subcondrais

B) Fator reumatoide positivo

C) Velocidade de hemossedimentação elevada

D) Acometimento da coluna lombar

QUESTÃO 03

ASS, 28 anos comparece ao consultório queixando-se de emagrecimento, dores do corpo com piora progressiva nos últimos 2 meses. Nega sintomas neurológicos, respiratórios, urinários e gastrointestinais. Relata muita astenia, dor em joelhos, tornozelos e com edema nos tornozelos. Ao exame está em bom estado geral, com mucosas descoradas moderadamente e com úlceras orais. Traz radiografia de tornozelo normal, hemoglobina =9g/dl, hematócrito = 26%; 90.000 plaquetas, 2000 leucócitos; urina 1 (EAS) com proteínas 2+. Assinale a alternativa que apresenta a principal hipótese diagnóstica e quais os exames para auxiliar na sua confirmação.

A) Artrite reumatoide, anti CCP e velocidade de hemossedimentação

B) Lúpus eritematoso sistêmico, anticorpo antinuclear e anti DNA

C) Síndrome de Sjogren, fator reumatoide e anti Ro

D) Hepatites virais, sorologias virais e pesquisa de crioglobulinemia.

QUESTÃO 04

O equilíbrio entre agentes anabólicos e agentes catabólicos determina a homeostase, e um desequilíbrio entre estes agentes, com predomínio dos catabólicos, ocasiona a degradação cartilaginosa observada na osteoartrite. Com relação à resposta catabólica dos condrócitos, a seguinte alteração é descrita:

A) diminuição da síntese de proteoglicanos.

B) diminuição da síntese de metaloproteases.

C) aumento da síntese de inibitor tecidual do plasminogênio.

D) aumento da síntese de colágenos tipo II e IX.

QUESTÃO 05

“A doença do manguito rotador pode se desenvolver apenas como tendinite ou evoluir para a ruptura.” Nesse contexto, torna-se indispensável realização de testes específicos que identificam a tendinite e de testes que avaliam a integridade dos tendões. Dentre os testes utilizados para avaliação da integridade dos tendões, incluem-se:

A) Neer e Hawkins.

B) Palm-up test e Yergason.

C) Jobe e Patte.

D) Gerber e Yocum.

QUESTÃO 06

VSB, sexo feminino, 32 anos, é encaminhada para ambulatório de reumatologia em uso antiinflamatórios, com dor intensa na mão direita. Relata que não gosta de atividades físicas e que fica muitas horas seguidas no uso de computador, tablet ou celular. O possível diagnóstico é a Tenossinovite Estenosante De Quervain, que abrange o primeiro compartimento dorsal (tendões do abdutor longo e do extensor curto do polegar). Assinale o teste adequado para a sua confirmação?

A) Thompson

B) Tinel

C) Finkelstein

D) Cosen

QUESTÃO 07

Os auto-anticorpos devem ser solicitados nos cenários em que se suspeita de uma doença inflamatória imunomediada. A dosagem positiva dos anticorpos anti-DNA dupla hélice e anti-Sm tem maior especificidade para o diagnóstico de

A) lúpus eritematoso sistêmico.

B) doença de Behçet.

C) doença mista do colágeno.

D) dermatopolimiosite.

QUESTÃO 08

Durante a expansão cutânea realizada para reconstrução de uma sequela de queimaduras, o que podemos observar na área tecidual operada?

A) Atrofia da derme

B) Hipertrofia da epiderme

C) Formação de cápsula fibrosa em volta do expansor

D) Todas estão corretas

QUESTÃO 09

Você está descrevendo os riscos e benefícios da expansão tecidual para os pais de uma criança que apresenta uma área de alopécia no couro cabeludo. Qual das seguintes alternativas constitui a principal vantagem da expansão tecidual para esta criança?

A) O menor número de procedimentos com anestesia geral

B) O menor número de consultas clínicas hospitalares

C) O defeito pode fechar diretamente utilizando um retalho de pele com cabelo

D) A reconstrução pode ser terminada rapidamente

QUESTÃO 10

Paciente 38 anos, masculino, tem acidente de carro e chega ao Pronto-socorro queixando-se de muita dor na coluna, e logo após exame clínico é feito a hipótese de fratura de coluna toracolombar, que é confirmado pelo R-x coluna torácica e lombar. É considerado critério de instabilidade na fratura explosão da coluna toracolombar:

A) cifose maior do que 10 graus

B) achatamento maior do que 20 graus

C) déficit neurológico

D) destruição da coluna média

QUESTÃO 11

Os primeiros cuidados no trauma de extremidades devem ser feitos pelo protocolo PRICE, onde é incorreto afirmar:

A) P significa proteção;

B) R significa repouso;

C) I significa imobilização;

D) C significa compressão leve;

QUESTÃO 12

Paciente após acidente motociclístico, apresenta fratura exposta de membro superior Esquerdo, com sangramento abundante. Para se estancar uma hemorragia devemos realizar a seguinte sequência:

A) Compressão direta do ferimento, elevação do membro, compressão da artéria proximal, pinçamento dos cotos vasculares e torniquete;

B) Elevação do membro, compressão da artéria proximal, compressão direto do ferimento, torniquete e pinçamento dos cotos vasculares;

C) Compressão direta do ferimento, compressão da artéria proximal, torniquete e pinçamento dos cotos vasculares, elevação do membro;

D) Compressão direta do ferimento, elevação do membro, compressão da artéria proximal, torniquete e pinçamento dos cotos vasculares;

QUESTÃO 13

Uma paciente de 24 anos, brasileira, foi submetida à plastica mamária (mastopexia com prótese) há 90 dias e queixa-se da qualidade de sua cicatriz. A mesma refere que apresenta ardência local eventualmente. Ao exame físico da cicatriz: encontra-se com coloração avermelhada, de consistência pouco mais endurecida e levemente elevada, porém não ultrapassando os limites da própria cicatriz. Essa paciente apresenta:

A) uma cicatriz queloidiana.

B) um tumor desmóide.

C) uma cicatriz hipertrófica.

D) um carcinoma basocelular.

QUESTÃO 14

Quanto à fratura exposta, temos os seguintes cuidados: I - não movimentar o acidentado; II - imobilizar o local atingido usando talas improvisadas; III - tentar colocar o osso no lugar, puxando as extremidades do membro afetado, para que não ocorra maior perfuração de órgãos ou rompimento de veias ou artérias; IV - amarrar a tala com tiras de pano, em lugares acima e abaixo do local fraturado; V - a vítima ser encaminhada ao hospital mais próximo. Dos procedimentos acima, o único totalmente INCORRETO:

As alternativas desta questão não estão presentes no arquivo fornecido.

GABARITO COMENTADO

Elaborado de modo independente das marcações existentes. Questões ambíguas e incompletas sinalizadas sem preencher lacunas por suposição.

01 C	**02 D**	**03 B**	**04 A**	**05 C**	**06 C**	**07 A**
08 D	**09 C**	**10 C***	**11 C**	**12 Sem única**	**13 C**	**14 III**

*Questão 10: C é a resposta clínica mais defensável; D tem apoio na classificação histórica de Denis. Questão 12: D pode ter sido a resposta esperada no modelo antigo, porém nenhuma sequência é inteiramente correta pela orientação atual. Questão 14: apenas os itens estão disponíveis; as alternativas não constam no arquivo.

QUESTÃO 01 | C

O quadro é típico de osteoartrite do joelho: dor mecânica, rigidez breve e crepitação. Referência(s): [1]

A. Incorreta. A artrite reumatoide costuma provocar sinovite inflamatória e rigidez matinal prolongada; não é o padrão predominante descrito.

B. Incorreta como hipótese principal. A doença por depósito de pirofosfato pode acometer joelhos, mas faltam episódios agudos de sinovite ou identificação de cristais/condrocalcinose.

C. Correta. Dor pior à deambulação, rigidez matinal de 25 minutos e crepitação favorecem osteoartrite.

D. Incorreta como melhor resposta. A condropatia patelar pode causar dor anterior no joelho, mas o quadro geral crônico favorece osteoartrite.

QUESTÃO 02 | D

O padrão de poliartrite inflamatória crônica de pequenas articulações com desvio ulnar sugere artrite reumatoide. Referência(s): [2]

A. Esperada. Erosões periarticulares/marginais são achados radiográficos da artrite reumatoide; o termo subcondrais do enunciado é pouco específico.

B. Esperada. O fator reumatoide pode ser positivo, embora sua negatividade não exclua a doença.

C. Esperada. A velocidade de hemossedimentação pode aumentar com inflamação ativa, sem ser específica.

D. Correta como a alternativa NÃO esperada. O acometimento axial típico da artrite reumatoide é cervical, não da coluna lombar.

QUESTÃO 03 | B

A combinação de úlceras orais, artrite, citopenias e proteinúria torna o lúpus sistêmico a hipótese principal. Referência(s): [3]

A. Incorreta. Artrite reumatoide isoladamente não explica tão bem as citopenias em múltiplas linhagens, úlceras e alteração urinária.

B. Correta. FAN/ANA auxilia na triagem; anti-DNA de dupla hélice é autoanticorpo específico e pode apoiar avaliação de doença renal lúpica.

C. Incorreta como melhor resposta. Sjögren costuma destacar sintomas de secura; anti-Ro pode ocorrer também no lúpus.

D. Incorreta como hipótese principal. Hepatites e crioglobulinemia são diferenciais em cenários apropriados, mas o conjunto descrito favorece lúpus.

QUESTÃO 04 | A

A resposta catabólica reduz a produção de componentes da matriz e favorece enzimas que degradam cartilagem. Referência(s): [4]

A. Correta. Citocinas como IL-1β e TNF-α podem reduzir a síntese de proteoglicanos.

B. Incorreta. Há tipicamente aumento, não diminuição, de metaloproteinases degradativas.

C. Incorreta como mecanismo descrito. O aumento de inibidores fibrinolíticos não representa a principal alteração catabólica; a via proteolítica é complexa.

D. Incorreta. A síntese de colágenos estruturais, sobretudo tipo II, é comprometida no ambiente catabólico.

QUESTÃO 05 | C

Jobe e Patte avaliam o desempenho de músculos/tendões do manguito, incluindo supraespinal e rotadores externos. Referência(s): [5]

A. Incorreta. Neer e Hawkins-Kennedy são manobras relacionadas predominantemente ao conflito subacromial.

B. Incorreta. Palm-up e Yergason são empregados na investigação da cabeça longa do bíceps.

C. Correta. Jobe e Patte são testes de força/função utilizados na avaliação dos tendões do manguito rotador.

D. Incorreta como conjunto. Gerber avalia subescapular, mas Yocum é sobretudo um teste de impacto subacromial.

QUESTÃO 06 | C

A tenossinovite de De Quervain envolve o primeiro compartimento extensor e é pesquisada com a manobra de Finkelstein. Referência(s): [6]

A. Incorreta. Thompson pesquisa integridade do tendão calcâneo (Aquiles).

B. Incorreta. Tinel investiga irritação/lesão de nervos periféricos, não sendo teste específico para De Quervain.

C. Correta. A manobra de Finkelstein reproduz dor no lado radial do punho em casos compatíveis com De Quervain.

D. Incorreta. Cozen (grafado "Cosen" no enunciado) é relacionado à epicondilite lateral do cotovelo.

QUESTÃO 07 | A

Anti-Sm e anti-DNA de dupla hélice apresentam especificidade relevante para lúpus eritematoso sistêmico. Referência(s): [3]

A. Correta. Os dois autoanticorpos estão entre os marcadores imunológicos específicos reconhecidos para o LES.

B. Incorreta. Behçet tem diagnóstico essencialmente clínico; esses anticorpos não o caracterizam.

C. Incorreta. A doença mista do tecido conjuntivo é mais associada a anti-U1-RNP de alto título.

D. Incorreta. Dermatomiosite tem outros perfis sorológicos, como anti-Mi-2 e anticorpos específicos de miosite.

QUESTÃO 08 | D

Na expansão tecidual convencional são descritas alterações histológicas nas três estruturas mencionadas. Referência(s): [7]

A. Verdadeira. Ocorre afinamento/atrofia relativa da derme sob tensão.

B. Verdadeira. Pode ocorrer espessamento/hiperplasia da epiderme.

C. Verdadeira. Forma-se cápsula fibrosa reacional ao redor do expansor.

D. Correta. A, B e C são achados documentados; portanto, todas estão corretas.

QUESTÃO 09 | C

A vantagem reconstrutiva é usar couro cabeludo expandido com fios de cabelo para cobrir área de alopecia. Referência(s): [7]

A. Incorreta. A expansão pode exigir implantação, expansão seriada e segundo procedimento; não garante menos anestesias.

B. Incorreta. Requer retornos ambulatoriais frequentes para expansão e acompanhamento.

C. Correta. Permite avançar pele do couro cabeludo que mantém unidades pilosas, com melhor semelhança de tecido.

D. Incorreta. Expansão convencional ocorre ao longo de semanas ou meses, e não é um método de finalização rápida.

QUESTÃO 10 | C*

Pelo critério clínico moderno, déficit neurológico caracteriza comprometimento importante; porém, a classificação histórica de Denis valorizava a lesão da coluna média. Questão ambígua entre modelos. Referência(s): [8,9]

A. Incorreta como critério isolado. Cifose superior a 10° não é, por si, limiar universal de instabilidade.

B. Incorreta como critério isolado. O enunciado fornece graus para achatamento, unidade inadequada; perda de altura precisa ser quantificada e interpretada com outros dados.

C. Mais defensável no contexto clínico. O déficit neurológico é um fator de gravidade e integra avaliações contemporâneas de lesões toracolombares, mas não define sozinho instabilidade mecânica.

D. Possível resposta histórica (ressalva). Na teoria de Denis a lesão da coluna média era considerada sinal de instabilidade; hoje, o envolvimento da coluna média também integra fraturas explosivas que podem ser estáveis.

QUESTÃO 11 | C

PRICE = Protection, Rest, Ice, Compression, Elevation (proteção, repouso, gelo, compressão e elevação). Referência(s): [10]

A. Correta como definição de letra. P corresponde a protection/proteção.

B. Correta como definição de letra. R corresponde a rest/repouso.

C. Alternativa INCORRETA solicitada. I significa ice (gelo), e não imobilização, embora imobilizar possa ser útil conforme a lesão.

D. Correta como definição de letra. C é compression, habitualmente compressão sem comprometer a perfusão.

QUESTÃO 12 | SEM ÚNICA

Nenhuma sequência é integralmente adequada aos protocolos atuais. A alternativa D possivelmente reflete um esquema didático antigo, mas NÃO deve ser adotada como orientação de atendimento. Referência(s): [11]

A. Inadequada. Começa com compressão direta, mas posterga o torniquete até depois de pinçamento de vasos, que não é rotina no primeiro atendimento.

B. Inadequada. Antecede a compressão direta por elevação e compressão proximal, atrasando o controle efetivo do sangramento.

C. Inadequada. Inclui etapas não recomendadas rotineiramente e deixa elevação por último; não expressa uma sequência segura padronizada.

D. Provável resposta tradicional, porém tecnicamente inadequada hoje. Compressão direta é apropriada; elevação e compressão proximal não são etapas obrigatórias, e pinçamento de cotos vasculares não deve constar de manobra leiga. Em sangramento grave de extremidade, torniquete pode ser necessário precocemente.

QUESTÃO 13 | C

A cicatriz hipertrófica se eleva e se torna firme/avermelhada, mas permanece nos limites da incisão original. Referência(s): [12]

A. Incorreta. Queloide habitualmente ultrapassa os limites da ferida original.

B. Incorreta. Tumor desmoide é proliferação fibromatosa profunda, e não uma cicatriz elevada típica da incisão.

C. Correta. Elevação restrita à linha cirúrgica, vermelhidão e endurecimento aos 90 dias caracterizam cicatriz hipertrófica.

D. Incorreta. Carcinoma basocelular não é explicado pela evolução comum de uma cicatriz recente e teria outros sinais clínicos.

QUESTÃO 14 | III

O procedimento III é o incorreto. Não se deve tentar realinhar por tração improvisada o osso exposto na cena; a redução, quando indicada, pertence à assistência habilitada. Referência(s): [13]

I. Adequado em termos gerais: evitar movimentação desnecessária do acidentado, especialmente se houver suspeita de outras lesões. Não significa proibir toda mobilização necessária para salvamento.

II. Adequado: imobilizar e apoiar o segmento com dispositivos apropriados ou improvisados, sem aumentar a lesão.

III. INCORRETO. Tração para colocar o osso no lugar, por pessoa não habilitada, pode lesar vasos, nervos e partes moles; não é medida de primeiros socorros.

IV. Adequado com cuidados: fixar a tala em pontos acima e abaixo da fratura, sem comprimir o local ou prejudicar a circulação.

V. Adequado: encaminhamento urgente para atendimento hospitalar, com proteção do ferimento e avaliação neurovascular.

REFERÊNCIAS CONSULTADAS

Links públicos verificados em outubro de 2026. A indicação de referências não converte itens ambíguos em questões com resposta única.

[1] NHS / Sherwood Forest Hospitals. Osteoarthritis care plan.
https://www.sfh-tr.nhs.uk/services/msk-together-partnership/self-care/osteoarthritis-care-plan/

[2] Rheumatoid factor and rheumatoid arthritis. Review (PMC, 2019).
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6491918/

[3] Aringer M et al. EULAR/ACR 2019 Classification Criteria for Systemic Lupus Erythematosus. Arthritis Rheumatol (2019).
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6827566/

[4] Goldring MB et al. Developments in the scientific understanding of osteoarthritis. Arthritis Res Ther (2009).
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2714096/

[5] AAOS. Rotator Cuff Clinical Practice Guideline, Appendix 2: Accuracy of Physical Examination Tests.
https://www.aaos.org/globalassets/quality-and-practice-resources/rotator-cuff/rotator-cuff-2025/rc-cpg-eappendix-2.pdf

[6] American Society for Surgery of the Hand. De Quervain Tenosynovitis.
https://www.assh.org/handcare/servlet/servlet.FileDownload?file=00P0a00000owAz9EAE

[7] Tissue regeneration during tissue expansion and choosing an expander. Indian J Plast Surg (2012).
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3385404/

[8] Management of burst fractures in the thoracolumbar spine. Asian Spine J (2016).
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4930335/

[9] WFNS Spine Committee. Indications for nonsurgical treatment of thoracolumbar spine fractures.
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8752701/

[10] MSD Manual. Entorses do tornozelo: princípios PRICE. Revisão 2025.
https://www.msdmanuals.com/pt/casa/les%C3%B5es-e-envenenamentos/entorses-e-outras-les%C3%B5es-dos-tecidos-moles/entorses-do-tornozelo

[11] American College of Surgeons. Stop the Bleed: técnicas de controle de hemorragia.
https://www.stopthebleed.org/get-trained/

[12] Cleveland Clinic. Hypertrophic Scar: diferenças em relação ao queloide.
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/21466-hypertrophic-scar

[13] American Red Cross. Fractures: first aid and immobilization.
https://www.redcross.org/take-a-class/resources/learn-first-aid/fractures

Nota sobre a fonte: o documento enviado contém 3 páginas, texto selecionável e nenhuma imagem incorporada. O enunciado e as alternativas disponíveis foram preservados; apenas cabeçalho administrativo e nota editorial de transcrição foram omitidos. Não foi criada nenhuma alternativa para a questão 14.